

BENDER

PRECAUSIONES PARA LA TOMA

OBJETIVO:

ASPECTOS PRINCIPALES EN LA REPRODUCCION DE LA GESTALTEN

1. Disposición

- 1.A Secuencia y sucesión
- 1.B Posición del primer dibujo
- 1.C. Posición general de los dibujos
- 1.D. Uso del espacio
- 1.E. Uso de los márgenes
- 1.F Giro o variación de la posición del papel
- 1.G Giro de la tarjeta

2. Alteraciones de tamaño

- 2.A. Aumento general en el tamaño de 5 o mas figuras.
- 2.B. Disminución en 5 o mas figuras.
- 2.C. Aumento o disminución progresivo
- 2.D. Aumento o disminución de un dibujo o de partes de un dibujo
- 2.E. Aumento en el plano vertical
- 2.F. Aumento en el plano lateral,
- 2.G. Tamaño irregular

3. Alteraciones de la forma

- 3.A. Dificultad en el cierre de la figura:
 - 3.A.1. Abertura en lugar de unión
 - 3.A.2. Remarcaciones
 - 3.A.3. Borraduras
 - 3.A.4. Presión es fuerte
 - 3.A.5. Presión débil
- 3.B. Dificultad de cruzamiento:.
- 3.C. Cambio en la curvatura:
 - 3.C.1. Aumento:
 - 3.C.2. Disminución:.
 - 3.C.4. Curvas acentuadas y aplastadas alternativamente
- 3.D. Cambios de angulación
 - 3.D.1. Aumento
 - 3.D.2. Disminución

4. Deformaciones o distorsiones groseras

- 4. A Rotación perceptiva
- 4. B Retrogresión
- 4. C Simplificación
- 4. D Fragmentación
- 4. E superposición
- 4. F Garabateo y elaboración
- 4. G Concretización
- 4. H Perseveracion
- 4. I Desplazamiento
- 4. J Fallo o repaso total

5. Dibujo

6. Movimientos

7. Método de trabajo

- 7.A. Detallismo:
- 7.B. Impulsividad:
- 7.C. Lentitud:
- 7.D. Líneas para encerrar los dibujos.
- 7.E. Ejecuciones demasiado perfectas

8. Análisis del trazo líneas

- 8.A. Trazo entero
- 8.B. Trazos entrecortados
- 8.C. Trazo profundo cuando deja huella del reverso del papel
- 8.D. Profundidad excesiva:
- 8.E. Trazo débil apenas roza el papel:
- 8.F. Trazo tembloroso:.
- 8.G. Anchura en el trazo:
- 8.H. Trazo grueso o línea pesada:.
- 8.I. Trazo repasado:
- 8.J. Trazo bosquejado:
- 8.K. Trazos Spikes:
- 8.L. Misceláneas:
- 8.M. Trazo normal:

9. Categorías básicas de observación psicológica

- 9.A. Agresivos
- 9.B. Impulsivos
- 9.C. Inseguros
- 9.D. Depresivos
- 9.E. Maniacos
- 9.F. Neuróticos

BENDER

PRECAUSIONES PARA LA TOMA

Para realizar la toma es necesario saber si posee problemas de visión, si toma alguna medicación o psicofármaco, y por último si es zurdo o diestro.

Se le presenta la hoja de forma vertical. Hoja N 4 Cada vez que se le presenta una tarjeta se la coloca alineada con la hoja en el borde superior izquierdo.

Lápiz negro faber n 2 hv con punta, observar como toma el sujeto el lápiz de acuerdo a eso va a ser el tipo de línea Vertical: trazo mas fino.

Acostado. Más grueso

Preguntar antes de la toma si consume algún tipo de medicamento (neurológico) ya que este tipo de medicación puede producir enlentecimiento de las reacciones, y una baja en la capacidad de atención y concentración. También preguntar por el uso de lentes y si es zurdo.

Consigna: "Le voy a mostrar una serie de láminas trate de copiarlas lo mas parecido posible, tal cual usted las ve".

Tiene dos lecturas una madurativa y la otra proyectiva. Cuando se analiza se obtiene información acerca de:

- A. nivel maduración vasomotora
- b. conflictos, defensas luchas del yo
- c. estructura de personalidad
- d. Organizaciones psicopatológicas y psiquiátricas

OBJETIVO:

El acto de percibir es un acto de integración y síntesis. El test sirve para determinar el nivel de madurez e niños y deficientes mentales. La función giestaltica visomotora es fundamental, esta asociada a la capacidad de lenguaje y a diversas funciones de la inteligencia: como la percepción visual, la memoria, la habilidad motora manual, los conceptos temporales – espaciales y la capacidad de integración. De ahí que midiendo el nivel de maduración de la función giestaltica, se pueda medir el nivel de maduración. Estas funciones están en estrecha relación con el sistema nervioso, por lo tanto el Bender sirve para detectar lesiones cerebrales, disritmias y síndromes orgánicos, esquizofrenia, debilidad mental infantil, demencias, retrasos globales de maduración, incapacitados verbales específicos, demencias paráliticas, alcoholismo, neurosis, tumores, epilepsias, psicopatías, etc.

ASPECTOS PRINCIPALES EN LA REPRODUCCION DE LA GESTALTEN

- 10. Disposición
- 11. Alteraciones de tamaño
- 12. Alteraciones de la forma
- 13. Deformaciones o distorsiones groseras
- 14. Dibujo
- 15. Movimientos
- 16. Método de trabajo

1. DISPOSICIÓN

1. A SECUENCIA O SUCESIÓN: se refiere al grado de regularidad con que el sujeto realiza las continuas colocaciones de los dibujos. La esperada en nuestro medio es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

- **Muy metódica o secuencia fija:** coloca los dibujos con rigidez cada uno debajo del anterior y por encima del siguiente. Utilización del margen izquierdo como apoyo o guía, la ubicación de los dibujos parece forzada y no tiene en cuenta la forma real o características del dibujo mismo. **Interpretación:** meticulosidad exagerada, funcionamiento intelectual rígido y controlado. Falta plasticidad. Se puede observar en personalidades excesivamente teóricas. Ansiedad encubierta. Puede ser resultante de querer mantener el control a través de un factor externo. Rasgos obsesivos de personalidad. Excesivo autocontrol. Compulsivos, yo débil.
- **Ordenada:** sigue una sucesión regular aunque permite una o dos excepciones o inversiones en el orden. **Interpretación:** común en sujetos normales, bien adaptados. Individuos con una buena automatización de los procesos lógicos del pensar, y que dejan un margen para el desarrollo de la inhibición. Indica plasticidad y flexibilidad. Indica adaptación y ajuste al medio indica un ajuste yoico adecuado.
- **Irregular:** se puede observar más de dos inversiones en el orden, aunque hay una secuencia lógica en la posición de las figuras. **Interpretación:** personalidad plástica, que no se encierra excesivamente en los modelos lógicos. Buena adaptación a situaciones nuevas
- **Confusa o caótica:** se realiza sin ninguna planificación previa. El resultado es una distribución muy desordenada, relajada y disgregada. **Interpretación:** se observa en psicóticos cuando hay secuencia confusa y alteración de la gestalt. sujetos neuróticos con gran ansiedad. Señala una inadecuación en la automatización de los procesos lógicos del pensar. Falta de disciplina mental. Se presentan en protocolos de sujetos maníacos y delirantes. No puede orientarse y posicionarse en su ambiente de un modo objetivo, fallará su criterio de la realidad. Su conducta será más o menos desajustada en función de otros indicadores.

1. B. POSICIÓN DEL PRIMER DIBUJO: Esta en estrecha relación con la actitud del sujeto ante situaciones nuevas o ante el medio ambiente

- Ubicar el primer dibujo en el **centro por debajo del margen superior.** **Interpretación:** es la posición mas frecuente. Indica buena adaptación a situaciones nuevas. Normal
- Ubicar el primer dibujo en el **rincón izquierdo superior.** **Interpretación:** individuos tímidos y temerosos, frecuentemente se acompaña de disminución en el tamaño como indicador de inhibición, búsqueda de seguridad.
- Ubicar el primer dibujo en el **centro de la pagina,** en general se acompaña de macrografía. El resto de los dibujos pueden aparecer en otras hojas o en las mismas. **Interpretación:** individuos narcisistas y egocéntricos, marcado oposicionismo, rasgo psicopático

1. C. POSICIÓN GENERAL DE LOS DIBUJOS: hay una correlación entre las posiciones generales de los dibujos y las conductas defensivas que el yo adopta, en situaciones nuevas.

- Figuras **colgadas de los extremos, aglutinación** de los dibujos a los ángulos del papel. **Interpretación:** incertidumbre, necesidad descontrolada de apoyo, inseguridad, temor a las relaciones interpersonales. Miedo a adoptar una actitud que pueda provocar el comentario de los otros. Temor a ser centro de atención, dependencia, inestabilidad emocional. Rasgo paranoide.
- Figuras **pegadas al margen:** **Interpretación** incertidumbre, necesidad de apoyo, temor a colocarse en el centro de atención.
- Figuras 1 a 8 colocadas arbitrariamente **alrededor de la tarjeta A.** **Interpretación:** características de personas egocéntricas, omnipotentes, narcisista y con rasgos psicopáticos de personalidad. También se observa en sujetos con gran monto de ansiedad o mal manejo de la misma
- Cada figura **separada de la otra por líneas** que se encierran. **Interpretación:** exagerada búsqueda de seguridad para compensar una marcada inseguridad. Necesidad de compensar la incertidumbre: rasgos fóbicos de personalidad. Necesidad de estructurar primero el espacio para así sentirse seguros manera de controlar la ansiedad y la inseguridad.
- Ubicar los dibujos en la **mitad superior de la hoja** dejando libre el resto. **Interpretación:** incertidumbre falta de adaptación a situaciones, búsqueda de seguridad, necesidad de defenderse del medio ambiente. Rasgos paranoides de personalidad. Vivencias de hostilidad provenientes de los otros.
- Usar **una hoja para cada dibujo** o cada dos dibujos. **Interpretación:** posición atípica y bizarra recuente en psicópatas y esquizofrénicos, o maniacos. Se acompaña generalmente de giro del papel. Si la necesidad de usar varias hojas se debe al aumento progresivo de tamaño, se interpreta como mal control de la ansiedad. Ansiedad abierta y reactiva, descontrol, falta de límites.
- Se considera normal la utilización de hasta dos carillas de papel.
- **Superpuestas o amontonadas:** dificultad para establecer entre si mismo y el ambiente, falta de consideración por los demás

1. D USO DEL ESPACIO: Revela las formas de percibir el mundo, amistoso u hostil, y la capacidad para expresar o reprimir la propia hostilidad

D.I. Se refiere al **distanciamiento de dos dibujos sucesivos**. Se investiga, inspeccionando los puntos adyacentes más próximos a dos figuras sucesivas. Analizaremos:

- DI.1 **Excesivo espacio** entre los dibujos como pauta típica del test. **Interpretación:** tendencias hostiles, fuertes y abiertas. Manifiesta extraversión. Se observa en individuos agresivos, rebeldes y de difícil adaptación.
- DI.2 **Poco espacio** entre las figuras como pauta típica del test. **Interpretación:** tendencias pasivas y esquizoide, conducta introvertida, hostilidad reprimida y vuelta hacia adentro, tendencias masoquistas, conducta poco segura, dificultad para exteriorizar sus emociones.
- DI.3 **Mucho espacio** entre los dibujos y figuras pequeñas (los dibujos aparecen como comprimidos en la pagina). **Interpretación:** frecuentemente en individuos activamente paranoides. Represión, el mundo se ve amenazante y hostil, falta de adaptación a situaciones nuevas. Conducta segura cotejar con la presión y estilo de trazo pero no exenta de una dosis de rebeldía y egocentrismo.

D.II. Se refiere a la **medida de las reproducciones** en relación con los estímulos del test, o sea, comprensión – expansión

- D II 1Tendencia **a reducir** el tamaño de la figura. Usar un espacio pequeño de la hoja y dejar el resto libre. **Interpretación:** superyo estricto, rigidez, falta de flexibilidad, restricción yoica, marcada inhibición.
- D II 2 Tendencia de las figuras a **superponerse**. No hay choque. **Interpretación:** es indicio de la fuerza del yo, implica falta de preocupación por los demás. Agresividad, incapacidad para captar las relaciones interpersonales. Sujetos que sufren confusión en los límites de su propio cuerpo. Puede indicar una perturbación motriz o neurológica. Dificultad para orientarse ante estímulos concretos.
- D II .3 **Choque o cohesión:** falta de atención por los límites. **Interpretación:** marcada perturbación en el funcionamiento del yo, individuos que no se preocupan por los demás y son muy agresivos con el medio. Esquizofrénicos, probable lesión cerebral, organicidad. Frecuente en psicóticos deteriorados.

1 E. USO DE LOS MÁRGENES: Se refiere a la colocación de cualquier figura a menos de 1cm de cualquiera de los bordes de la hoja.

- **E.1 Dibujo ubicado a lo largo de la hoja del papel Interpretación:** el sujeto necesita apoyo para su seguridad y ansiedad. Representa un intento de mantener el control a través de un sostén externo, puede ser ocasionalmente un rasgo paranoide. Se ve en sujetos con lesión cerebral, como intento de manejar una situación ante la que se sienten impotentes de resolver.
- **E.2 Dividir la hoja por medio de una línea vertical y colocar los dibujos en el margen izquierdo y junto a la línea divisoria. Interpretación:** inseguridad ansiedad encubierta, rasgos paranoides, yo débil a pesar de que el sujeto intenta controlar la debilidad.

1 F. GIRO O VARIACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PAPEL

- **f.1De 90: Interpretación:** sujetos egocéntricos y omnipotentes, rasgos psicopáticos Rotación parcial cuando se da en uno o dos casos.
- **F.2 De 180 0 mas: Interpretación:** marcada tendencia opositorista, negativismo. Frecuente y normal en adolescente.
- **Rotación extrema se da entre tres y ocho figuras: Interpretación** correspondiente a las dos rotaciones: tendencias opositoriales, conductas obstinadas, inquietos o detallistas.

1 G. GIRO DE LA TARJETA: se refiere al cambio de posición de la tarjeta estímulo de su posición original. La posición correcta es con el eje longitudinal paralelo al cuerpo del examinado. **Interpretación:** igual a la del giro de papel, puede haber lesiones cerebrales.

2. ALTERACIONES DE TAMAÑO: Se considera que el tamaño del dibujo está aumentado o disminuido cuando sus ejes horizontales o verticales son mayores en la mitad o más de que el eje de las figuras modelos, sin que se altere la gestalt. El aumento o disminución debe ser observado en la mayoría de los dibujos. El tamaño está directamente relacionado con la ansiedad. El tamaño ligado al equilibrio emocional.

- **Aumento general en el tamaño de 5 o mas figuras.** A veces necesitan utilizar varias hojas. **Interpretación:** formación reactiva frente a marcados sentimientos de ansiedad, el sujeto niega la ansiedad. Excesivo nivel de aspiración, falta de control de la ambición, mal manejo de la ansiedad.,falta de control e inhibición yoica. Predominio de componentes narcisistas y necesidad de exhibición personal frente al ambiente, necesitan sobresalir en el ambiente. Gran extraversión, probable en sujetos agresivos, conducta compensatoria, implica ansiedad.
- **Disminución en 5 o mas figuras.** **Interpretación:** asociado a intensa ansiedad encubierta, inhibición. El sujeto no se puede defender de sus conflictos. Rigidez, retraimiento, superyo severo. Personalidad controlada sin una adecuada expresividad. Inhibición de la espontaneidad Tendencia a retraerse a inhibirse y falta de espontaneidad en sus relaciones interpersonales Sujetos emocionalmente bloqueados. Rasgos depresivos, rigidez en lo conductual.
- **Aumento o disminución progresivo** del tamaño de los sucesivos dibujos (o por lo menos una figura excesivamente grande o pequeña. **Interpretación:** Poco equilibrio, bajo nivel a la tolerancia a la frustración. Individuos irritables, explosivos y peligrosos, que pueden comprometerse en una gran cantidad de acting-out, rasgos psicopáticos. Si la disminución o aumento se encuentran en figuras de semejanza fálica, se puede interpretar como conflicto sexuales; represión, rasgo histérico de la personalidad. (Fig. A y 1).Cuando el aumento cada vez es mayor la conducta manifiesta es irritable explosivo, probable perdida de control y un actuar impulsivo. Cuando es menor inhibición frente al medio, tendencias depresivas, inseguridad.
- **Aumento o disminución de un dibujo en particular o de partes de un dibujo,** especialmente si se diferencia de las características del tamaño de los otros. **Interpretación:** señal de conflicto en el sujeto frecuentemente se observan perturbaciones sexuales. El aumento en el plano vertical se asocia al conflicto con Fig. totalitarias. En cambio plano horizontal dificultad para establecer relaciones interpersonales
- **Aumento en el plano vertical,** si la figura tiene orientación de arriba hacia abajo. (Fig. 7). **Interpretación:** Dificultad con figuras totalitarias o autoritarias. ¿
- **Aumento en el plano lateral,** si la figura es más ancha que alta. (Fig. 8). **Interpretación:** Dificultad en las relaciones interpersonales; mal establecimiento de adecuadas y satisfactorias catexias.
- El **Tamaño irregular:** Figuras de diferentes tamaños: Cambios de conducta, ambivalencia marcada, manejo labil de los estados afectivos y de sus impulsos.

3. ALTERACIONES DE LA FORMA: Los factores a tener en cuenta están relacionados con algún grado de cambio en las características gúestaticas, pero en ningún modo en una distorsión grosera de la misma. La forma es igual al estilo cognitivo y este es la forma en que el sujeto percibe (lo que ve) ya percibe lo que siente y lo que ve) es decir la interpretación que el sujeto da d e la realidad.

3. A. Dificultad en el cierre de la figura: Se da al juntar una figura o dos figuras adyacentes (A, 4, 5, 6,7 ,9 8) Lo ideal seria que la unión se produzca

espontáneamente. Dificultad para establecer relaciones interpersonales adecuadas. Ya que le genera ansiedad o temor. Significativo a partir de los 8 años.

3. A.1. Separación, espacio en blanco entre dos partes A ,1)

3. A.2. Brecha, abertura en el contorno continuo (A ,8)

3. A.3. Extensión continúa más allá de una línea mas allá del punto de unión (7,8)

3.A.4. “orejas de perro o de burro” tentativa de hacer un ángulo mas allá de la línea de unión (7) b. **Interpretación:** Temor a las relaciones interpersonales. Incapacidad para mantener catexias constantes con adecuados objetos del medio. Perturbaciones emocionales. En general se lo interpreta como desadaptación social. También se ve en lesionados cerebrales.

Abertura en lugar de unión: implica que el sentimiento de unión con el otro el sujeto adopta un actitud distante que le cuesta franquear.

Remarcaciones: de acuerdo adonde estén situadas demuestran que ese vínculo al sujeto le genera ansiedad o angustia. En la A y 1 es femenino –masculino en la 7 autoridad padre, 8 vinculo materno.

Borraduras nivel de autoexigencia o marcan algún punto en el que el sujeto se siente débil.

Presión es fuerte: en los puntos de unión se interpreta mala regulación de impulsos.

Presión débil el sujeto se debilita o recibe demasiada presión exterior.

3. B. Dificultad de cruzamiento: Se da en la figura 6 y 7 donde una línea cruza a la otra. Se manifiesta por un marcado aumento de la presión del lápiz, repaso, garabatos, borraduras en el punto de intersección. **Interpretación:** Bloqueo psicológico, abulia, indecisión; duda compulsiva, fobias, dificultades en las relaciones interpersonales. Puede ser indicador de organicidad.

3. C. Cambio en la curvatura: Cualquier modificación obvia en las líneas curvas (4, 5 y 6) Se observan en las adicciones, alcoholismo muchos cambios en la curvatura.

- **Aumento:** La curvas se tornan mas manifiestas (mayor altura). **Interpretación:** Gran respuesta a estímulos emocionales. Individuos lábiles afectivamente. Se presenta en maníacos (6,4) Hiperactividad emocional .No hay relación entre el estímulo y la reacción el sujeto reacciona con irritabilidad de carácter que no corresponde a la magnitud de la relación.
- **Disminución:** Tendencia a la rectangulación. **Interpretación:** Indica atenuación o supresión de afectos e insensibilidad a estímulos externos. Bloqueo; superficialidad en las expresiones emocionales; represión.
- **Curvas acentuadas y aplastadas alternativamente,** se acompañan de ángulos redondeados o acusados. (6). **Interpretación:** Dificultad en controlar las emociones, labilidad afectiva, distimia. Manifiestos cambios en la expresión emocional (mal control de las emociones) Neurosis. Empequeñecimiento: conductas agresivas hacia el ambiente.

3.D Cambios de angulación: Se debe observan en por lo menos 4 figuras es el aumento o disminución en mas de 10 grados en la angulación (A, 2,3,4,5,6,7 y 8)La modificación de la angulación refleja la dificultad del sujeto para enfrentarse con estímulos afectivos (problemas en el control de la afectividad y los impulsos). Significativo si ocurre una o más veces. Cuando lo afectivo este en juego le costara encontrar conductas adaptativas para dar respuestas alas situaciones. En Los alcohólicos aparece.

- **Aumento:** implica un cambio hacia la rectangulación o la obtusidad (ángulos obtusos o rectos en lugar de agudos). Interpretación: Bloqueo, falta de

expansión; represión afectiva, inhibición. Trastornos de coordinación visomotora. Puede proceder de algún trastorno orgánico. El sujeto reacciona con apatía o frialdad reprimiendo el sentimiento que esta por debajo.

- **Disminución:** Los ángulos son más agudos de lo que deberían ser. Incapacidad para lograr los ángulos que forman dos figuras entre si; suelen aparecer orejas de perro o de burro (8). Interpretación: Excesiva reacción emocional a estímulos externos; hipermotividad y/o marcada agresividad. Sentimiento de inseguridad, intento de controlar un trastorno o conflicto subyacente. Alta reactividad y susceptibilidad, rápidamente herido en su amor propio.

4. DEFORMACIONES O DISTORSIONES GROSERAS: Son indicadores de una severa patología, a veces su presencia se puede deber a algún otro factor no patológico. La aparición de una o más distorsión dentro de un protocolo alerta de una probable perturbación severa. En sujetos neuróticos la presencia de los mismos es circunstancial. En sujetos psicóticos y orgánicos es habitual. Las distorsiones representan la perdida del control del yo. Las mismas son:

- 4. A Rotación perceptiva
- 4. B Retrogresión
- 4. C Simplificación
- 4. D Fragmentación
- 4. E superposición
- 4. F Garabateo y elaboración
- 4. G Concretización
- 4. H Perseveracion
- 4. I Desplazamiento
- 4. J Fallo o repaso total

4. A Rotación perceptiva: Es la rotación del eje mayor de la figura, estando la hoja de papel y la posición de la hoja correcta. (no confundir con el desplazamiento de una de las partes) .Factores que originan su aparición: la edad el nivel de maduración visomotor sin que sea a lo mejor patológico. La gravedad depende de la amplitud de la rotación. **Inferencias psicológicas:** depende de varios factores: edad, nivel de inteligencia, el grado de rotación y la cantidad de figuras en donde esto se da. En general se trata de un déficit en el funcionamiento yoico. Las rotaciones ascendentes pueden indicar un grado de excitabilidad que puede redundar en actitudes de oposicionismo y agresividad. Las rotaciones descendentes denotan estados depresivos y déficit energético.

No se interpreta en niños ni en adultos de bajo nivel intelectual.

- **Rotación de 10 a 15 grados:** siguiendo las agujas del reloj (Fig. A). **Interpretación** Tendencias defensivas y puede aparecer en defensivos por la caída del tono psicomotor.
- **Rotación de 50 a 90 grados:** Siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj (inversión o rotación perceptiva mediana) **Interpretación:** Tendencias antagónicas u oposicionistas. Se observa en disléxicos, individuos con problemas de lateralidad, lesionados cerebrales epilépticos, intoxicados graves y esquizofrenias.
- **Rotación de 90 a 180 grados:** rotación de la figura en forma completa en relación al papel **Interpretación:** trastornos de orientación temporoespacial y lateralidad: dislexias, esquizofrenia, estado confusionales y pacientes orgánicos.
- **Retrogresión primitivización o sobre simplificación:** es la sustitución del estímulo por una gestalt mas primitiva. **Interpretación:** profunda

perturbación de la personalidad (perdida de efectividad en el funcionamiento del yo). En general es indicador de debilidad mental, organicidad (aparecen espirales, dificultad en la coordinación motora, trastorno rotativo perceptivo) o rasgo psicótico. El diagnóstico diferencial depende de el nivel de maduración visomotora y la presencia o ausencia de elementos insólitos en el protocolo. En algunos casos cuando aparece en una o dos tarjetas (1,5) la sustitución de puntos por círculos y no existe otro factor de distorsión de la gestalt puede indicar inmadurez emocional. Fallos en el funcionamiento e integración del yo. Sujetos que no se adecuan para resolver situaciones presentes. Las desviaciones mas comunes son sustituir:

- con círculos los puntos y óvalos fig 1,2,3,5
- con guiones los puntos u óvalos fig 1,2,3,5
- con puntos los óvalos fig. 1,3,5
- con garabatos los puntos u óvalos fig 1,2,3,5
- con arcos los ángulos fig A 4,8
- con arcos los ángulos agudos u obtusos fig 3,7,8
- con bucles las curvas los puntos y óvalos fig. 1,2,3,4,5,6
- con espirales no radiados por puntos y óvalos fig 1,2,3,5

4. C. SIMPLIFICACION O CONCRECION: la gestalt es reemplazada por una forma mas “completa” pero que para el sujeto resulta mas fácil de hacer Ej. fig 7 dibuja un rectángulo o un octágono en lugar de los hexágonos. **Interpretación:** aparece en psicóticos (no percibe la alteración del dibujo en relación al modelo) cuando hay incapacidad para manejar una situación real (sentimiento de impotencia) y en las lesiones cerebrales (intenta corregir el dibujo, hay conciencia de la falla y autocrítica). Puede aparecer en psicopatías, el sujeto simplifica para no esforzarse, por la dificultad de coordinación motora debido a su impulsividad y precipitación.

4. D. FRAGMENTACION: La parte del todo se presenta disociada. El sujeto rompe la gestalt y reproduce sólo una parte. **Interpretación:** Trastornos de organización. Percepción inadecuada y o dificultades motoras (el sujeto dice que le es imposible realizarlo como el modelo, no tiene fallas en la percepción). Pueden ser pacientes orgánicos o esquizofrénicos. Afásicos, amnésicos, psicosis y ocasionalmente en histerias.

4. E- SUPERPOSICION: superpone los dibujos de una misma tarjeta entre sí. En la Fig. a, 4, 5,7, 8.

- **Penetración:** Superpone partes que sólo deberían tocarse. Se da en cuadros de organicidad, lesiones cerebrales, intoxicaciones y síndromes confusionales agudos.
- **Absorción:** Las partes se tocan, la punta de una falta debido a la intersección de la otra. Se da en lesiones cerebrales y en niños menores de cinco años es común.

Se debe hacer un diagnóstico diferencial con: problemas visuales, dificultad para el control motor y espacial.

4. F GARABATEO Y ELABORACION: El estímulo sirve al sujeto para crear otra gestalt diferente a la dada. **Interpretación:** Agitación y escasa concentración, perdida del funcionamiento del yo y hay una profunda alteración. Aparece en la esquizofrenia (elabora y destruye la gestalt) y en la manía (sólo la elabora) **Inferencias psicológicas:** implica una gran dificultad para el control de los impulsos y una gran ansiedad que se hace muy evidente en el comportamiento del sujeto

4. G CONCRETIZACION: El sujeto maneja la gestalt a un nivel concreto y le adjudica un sentido específico Ej.: Fig. 3 dice que es un racimo de uvas. **Interpretación:** Regresión y pensamiento patológico aparece en: esquizofrenia, psicosis, lesión cerebral, oligofrénicos y cuadros orgánicos y a veces psicopatías graves. **Inferencias psicológicas:** implica una gran dificultad para el control de los impulsos y una gran ansiedad que se hace muy evidente en el comportamiento del sujeto

4. H. PERSEVERACION: es la repetición del estímulo puede ser perceptual y motora

- **Perceptual:** persiste el patrón de la tarjeta anterior en la siguiente o en las siguientes. Aparece en esquizofrenias, psicosis alcohólicas, drogadicción y cuadros confusionales agudos
- **Motora:** repetición de una o mas unidades de las que exige el estímulo (se da en la misma tarjeta) de da en lesión cerebral, detención del desarrollo, epilépticos, disrítmicos niños con disfunción cerebral mínima y oligofrénicos

4. I. DESPLAZAMIENTO: se da cuando las diversas partes de la figura aparecen relacionadas de una manera desviada. **Interpretación:** sujetos que reaccionan de una manera atípica extraña y probablemente negativa ante la tarea. Es común en los deterioros orgánicos, en esquizofrenias y en psicopatías por reacciones precipitadas

4. J. REPASO O FALLO TOTAL: consiste en el fracaso ante la realización de una tarjeta. El sujeto no borra sino que tacha ya sea al finalizar la figura o antes de hacerlo. Puede dejar varios dibujos incompletos, intentando corregir el primero. **Interpretación:** indicador de un alto monto de ansiedad, tanto que le impide al sujeto la posibilidad de planificar una tarea y a la vez lo factible de modificarla. Bajo nivel de tolerancia a la frustración. Rasgo neurótico

5. DIBUJO: Se Refiere al tipo de líneas utilizadas intensidad y continuidad de las mismas

- **Misceláneas:** hacer muchas líneas abortadas, el producto final es una mala gestalt. Interpretación: Ansiedad
- **Espigas o Spikes** trazado saltativo y en puntas. Interpretación: rasgo epileptoide
- **Incoordinación motora:** movimientos irregulares, pobre control motor. Interpretación: temblores y espasmos provocado por algún cuadro orgánico. Indica tensión y ansiedad.

Calidad de la línea: tipo de línea:

- **Pesada:** impulsiva, enérgica, que casi rompe el papel. **Interpretación:** agresión, hostilidad frente al ambiente, rasgo epiléptico y/o psicopático.
- **Débil:** esbozada, casi imperceptible. **Interpretación:** ansiedad, timidez, falta de autonomía y auto conformismo, vacilación. Rasgo depresiva
- **Exageradas sin control.** **Interpretación:** Incapacidad para una fácil inhibición de los impulsos. Rasgo psicopático.
- **Bosquejo:** repaso con trazos repetidos, hace una línea previa que luego une o borra. **Interpretación:** frecuente en sujetos normales de espíritu crítico, con libertad de modificar y posibilidad de conformar a los adultos.

6. MOVIMIENTO: Lo característico es seguir la dirección opuesta a las agujas del reloj en las figuras cerradas. Si la dirección que sigue el sujeto es en el sentido de las agujas del reloj, se sospecha zurdera, actitudes opositoristas, problemas de

lateralidad o rasgo orgánico.(Fig. A). Si los movimientos que el sujeto ejecuta son de afuera hacia adentro nos hablaría de una personalidad egocéntrica y narcisista.(A, 8) Cuando el sujeto muestra discrepancia entre las direcciones de sus dibujos, puede estar relacionado con bloqueo emocional pero con intentos de solucionar los conflictos. (8). En la figura 4,5 y 6 si la dirección de las líneas en la parte oblicua es de afuera hacia adentro, indica un rasgo de introversión. Si las mismas son de adentro hacia fuera indican características de extroversión.

7. METODO DE TRABAJO. Hace Referencia al tipo de pautas de conducta que se manifiesta a lo largo de la prueba

- **Detallismo:** preocupación por alguna parte del dibujo. Repasa, borra, presiona al dibujar. Interpretación: indica conflictos de análisis del mundo exterior. Puede ser indicador de conflictos sexuales si se dan las (figuras 7y 8)
- **Impulsividad:** dibujo muy rápido sin planeamiento ni autocrítica. Interpretación: incapacidad para tolerar las frustraciones
- **Lentitud:** Tiempo de ejecución prolongado. Interpretación: marcada autocrítica y exigencia súper yoica. Rasgo depresivo
- **Líneas para encerrar los dibujos** que por lo general se acompaña de microscopia. Interpretación: Índice de aislamiento. Rasgo fóbico o paranoide.
- **Ejecuciones demasiado perfectas**, que suele acompañar de uno o dos rasgos bizarros, como por ejemplo rotaciones perceptivas. Interpretación: defensa contra una incipiente desorganización del yo. Perturbación orgánica o esquizofrenia incipiente

ANALISIS DEL TRAZO LINEAS:

- **Trazo entero:** Implica buena coordinación integridad yoica, buena discriminación yo no yo, ajuste adecuado del sujeto firmeza e integrado frente al ambiente y sus circunstancias. Puede utilizar adecuadamente el control de los impulsos y la represión.
- **Trazos entrecortados:** fragilidad yoica, probable impulsividad, ansiedad elevada, debilidad de la adaptación del sujeto al medio.
- **Trazo profundo cuando deja huella del reverso del papel:** Buen dinamismo psicofísico salud conservada, fortaleza yoica, buen rendimiento y actividad.
- **Profundidad excesiva:** casi rompen la hoja desborde de impulsos agresividad marcada. Se lo denomina también trazo hipertónico: rigidez, arritmia
- **Trazo débil apenas roza el papel:** Actúa de forma dependiente no autónoma muy sensible al medio. trazo hipotónico, labil, falta de autoconfianza, timidez que hace que el sujeto vacile y se sienta incomodo ante situaciones nuevas personales o ambientales.
- **Trazo tembloroso:** Oscila en profundidad por zona. Puede ser algo neurológico o alto grado de ansiedad.
- **Anchura en el trazo:** Ligada al equilibrio entre la sensualidad y la sensibilidad mas débil mayor sensibilidad y por lo tanto permeabilidad del sujeto respecto al medio. Lo que puede dotarlo de un buen poder de captación del entorno(mas empático) , pero también puede involucrar un estado de ansiedad inhibición o desorganización del si mismo
- **Trazo grueso o línea pesada:** Alto nivel de ansiedad, asociado cuadros adictivos, psicopatías, orgánico y epilepsia.

- **Trazo repasado:** Monto de ansiedad actitud perfeccionista, falta de anticipación.
- **Trazo bosquejado:** A) da a la ejecución aspecto desprolijo repasos excesivos sobre todo en puntos de unión relación con sentimientos de inadecuación con intentos compensatorios. B Artístico: búsqueda de gestalt adecuada y sentimiento de estética.
- **Trazos Spikes:** Irregular y anguloso: Agresividad, inseguridad y patologías orgánicas
- **Misceláneas:** Sumatorias de pequeños trazos que intentan dar la apariencia de un trazo entero. Ansiedad, inseguridad, débil afirmación del yo en relación al ambiente
- **Trazo normal:** Entero profundidad normal, grosor intermedio y ausencia de retoques , brizados temblorosos, bosquejados

Categorías básicas de observación psicológica en el test de Bender:

- **Agresivos:** Amontonamiento, superposición, figuras ejecutadas contra el margen derecho, ángulos agudos
- **Impulsivos:** macrografía, líneas enérgicas prolongadas, puntos rellenos, líneas prolongadas mas allá de su limite, ángulos redondeados
- **Inseguros:** Micrográficas, enmarcamiento de figuras, figuras colgadas en cantos, líneas esbozadas tenues, ángulos acusados, espacios en blanco en el trazo.
- **Depresivos:** Perfeccionismo e inconformismo ante su trabajo, rotación
- **Maniacos:** elaboraciones verbales o motoras, macrografías, usar una hoja por tarjeta
- **Neuróticos:** Secuencia ordenada (1º2 cambios), cada figura enmarcada por líneas (fobias), dificultad del cruzamiento (a través del repaso o borraduras) dificultades en el cierre,(temores al contacto), repaso total de la figura por ansiedad, tachadura o enmienda, diferencia de tamaño intrafigura, achatamiento o acentuación de las curvas, contar los puntos en las laminas.